

RELLENO TRIDIMENSIONAL DE OJERAS

Una Guía Completa con la Metodología ARTI



DR. JOÃO PITHON

2. REOLOGÍA

La elección del producto de relleno correcto se basa en su **reología**, es decir, en las características físicas que determinan cómo se comporta el producto en el tejido. En la región infraorbitaria, donde la piel es extremadamente fina, es fundamental utilizar productos con **bajo Swelling Factor** (factor de hinchazón). Estos productos se integran mejor a los tejidos sin causar hinchazón ni acumulación visible de material.

3. TÉCNICA

La técnica de aplicación es otro pilar fundamental de la Metodología ARTI. Utilizar **microcánulas** para inyectar el producto en las capas correctas minimiza el riesgo de traumatismos y ofrece un mayor control sobre la profundidad de la aplicación. La **retroinyección** —liberar el producto de forma gradual mientras se retira la cánula— garantiza una distribución más homogénea y reduce el riesgo de acumulaciones superficiales. La **técnica de relleno por capas** es un excelente ejemplo de refinamiento: al aplicar el producto en capas progresivas, comenzando por la región malar, el profesional crea una base tridimensional para el área infraorbitaria.

4. INTERCURRENCIAS

Manejar complicaciones como el efecto Tyndall o el edema es esencial para garantizar la seguridad del paciente. La **Metodología ARTI** enfatiza la prevención, pero también ofrece estrategias para afrontar los problemas cuando surgen.

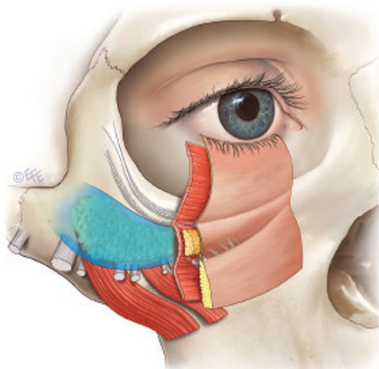
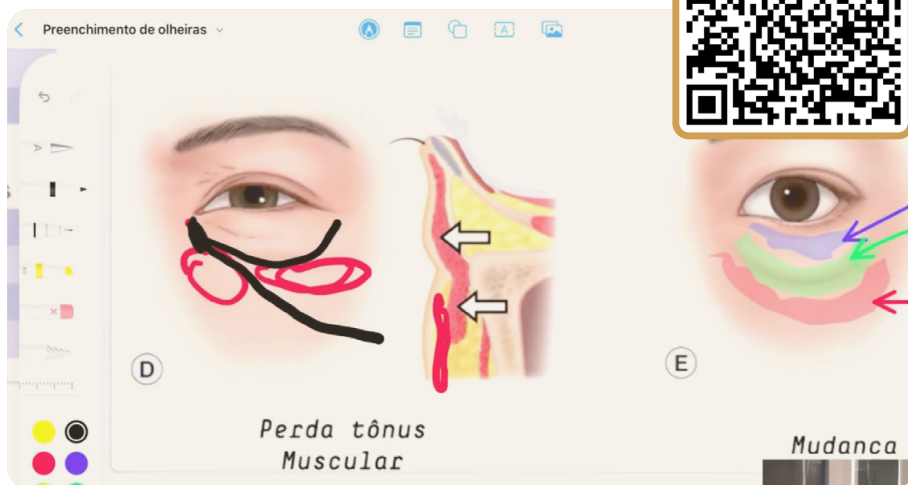


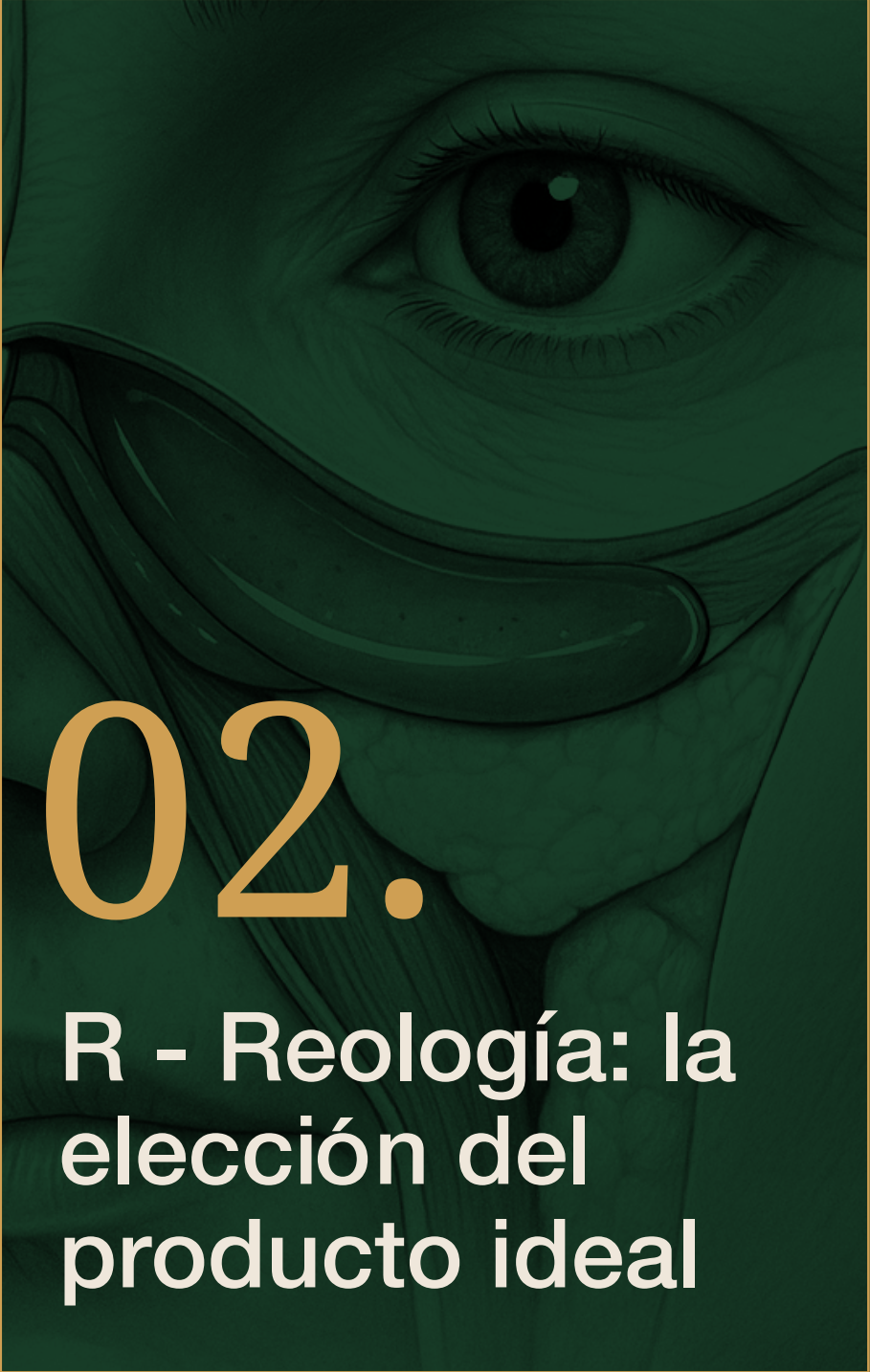
Fig. 1.211 Illustration of the anatomical depth relationships in the upper midface. The prezygomatic space is demonstrated in the deep suborbicularis plane (blue capsule). The orbicularis oculi muscle is demonstrated arborizing through the orbicularis oculi muscle inserting into the skin forming the tear trough crease. The zygomaticocutaneous ligaments arborize through the orbicularis forming a partition between the infraorbital "malar" fat compartment superiorly and superficial cheek compartment inferiorly. The cutaneous insertion of the ligaments forms the characteristic skin crease demonstrated in clinical malar mounds.

Source: *The Midface*, In: *Lamb J, Suresh C, ed. Facial Volumization: An Anatomic Approach*. 1st Edition. New York: Thieme Medical Publishers, Inc.; 2017. doi:10.1055/b-005-143644

¿QUÉ ES LA SOOF?



Por último, la **grasa orbitaria profunda**, que se sitúa más hacia el reborde óseo de la órbita, también pierde volumen con el tiempo y, con el aumento de la flacidez, se produce un prolapso de esta grasa que evidencia las bolsas infraorbitarias.

A close-up, artistic illustration of a person's face, focusing on the right eye. The person is wearing a surgical mask, which is visible as a dark, curved shape below the eye. The skin is rendered with fine, dark lines, giving it a textured, almost anatomical appearance. The background is a solid dark green color.

02.

R - Reología: la
elección del
producto ideal

En el manejo del edema persistente, el tratamiento adecuado será la aplicación de hialuronidasa, con el fin de retirar el material que está provocando el edema persistente. Antes de realizar la retirada del material es fundamental acordarlo con el paciente y evaluar el caso de forma presencial, para conducirlo de la mejor manera posible. Existen casos en los que caben medidas previas al uso de la hialuronidasa según la clínica del paciente, como por ejemplo el uso de corticoide oral (p. ej., prednisona 40 mg/día) y el drenaje mecánico de la región. Sin embargo, si el edema persiste, la hialuronidasa será el tratamiento definitivo; si es necesario, se rehace el relleno de la región con la técnica y el producto adecuados, y se espera al menos 48 horas siempre que no haya edema ni hematomas.



Hialuronidasa en
la región orbitaria



Hialuronidasa en
la región orbitaria

